

Fibrilação atrial · ritmo e anticoagulação

Na FA, primeiro estabilize (ABC e frequência). Depois decida anticoagulação pelo risco embólico e escolha controle de frequência versus ritmo conforme duração, sintomas e risco de trombo.

Instabilidade = cardioversão

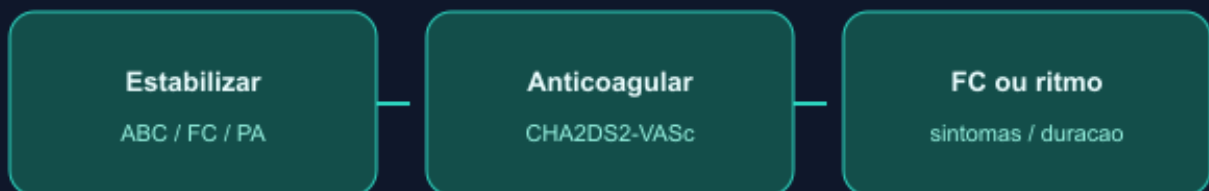
Lembre - Instabilidade = cardioversão

Hipotensão, choque, isquemia miocárdica, EAP ou rebaixamento atribuíveis à FA !' cardioversão elétrica sincronizada sem atrasar por jejum/anticoagulação plena se risco de vida.

Fluxo de prova: tratar instabilidade primeiro; anticoagulação é decisão paralela ao controle de FC/ritmo.

Abordagem da FA

Estabilizar -> anticoagular -> estrategia



Controle de frequência (estável)

- Betabloqueador ou antagonista de cálcio não-di-hidropiridínico (diltiazem/verapamil) se FE preservada
- Digoxina: útil em IC/hipotensão relativa; menos eficaz no esforço
- Amiodarona EV: opção quando há IC com FE reduzida e necessidade de controle
- Alvo usual de FC em repouso ~ <110 bpm na estratégia leniente, se assintomático

Anticoagulação — visão de prova

Cenário | Conduta típica

CHA₂DS₂-VASc "e2 &B / "e3 &@ | Anticoagular (DOAC preferencial se elegível)

FA "e48 h ou duração incerta | Anticoagular "e3 sem antes de cardioversão eletiva (ou ETE sem trombo)

Pós-cardioversão | Anticoagular "e4 sem se risco elevado / duração longa

Valvulopatia reumática/prótese mecânica | Varfarina (não DOAC)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não cardioverta eletivamente FA de duração >48 h sem anticoagulação adequada ou exclusão de trombo atrial (ETE). Risco de embolia sistêmica é clássico em R1.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

CHA2DS2-VASc indica anticoagulação e HAS-BLED estima risco de sangramento na fibrilação atrial.

Homem "e2 ou mulher "e3: anticoagular (DOAC preferencial na maioria).

CHA2DS2-VASc

Risco tromboembólico

C - ICC / FE reduzida	1
H - HAS	1
A2 - Idade ≥ 75	2
D - Diabetes	1
S2 - Stroke/AIT/TE previo	2
V - Doença vascular	1
A - Idade 65-74	1
Sc - Sexo feminino	1

C H F = 1 cada; A2 = 2; D = 1; S2 = 2; V A Sc = 1 cada

"e3 = alto risco — corrigir fatores modificáveis; não é contraindicação absoluta isolada.

HAS-BLED

Risco de sangramento

H - Hipertensão (PAS > 160)	1
A - Função renal/hepática anormal	1+1
S - Stroke previo	1
B - Sangramento previo / diatese	1
L - INR labil (se varfarina)	1
E - Idoso > 65	1
D - Drugs/alcool (antiagregante/AINE/etanol)	1+1

H A S B L E D = 1 ponto cada (em geral)

Controle de frequência vs ritmo

Estratégia | Quando

Frequência | maioria estável; meta FC em repouso geralmente < 110 se assintomático

Ritmo | sintomas refratários, 1º episódio selecionado, IC com FA de início recente

Cardioversão elétrica | instabilidade (choque, isquemia, edema agudo)

Anticoagulação — pontos de prova

- DOAC preferível à varfarina na FA não valvar (salvo contraindicação)
- Valva mecânica / estenose mitral moderada-grave: varfarina
- Se FA > 48 h ou duração incerta: anticoagular 3 sem antes de CVE eletiva ou EcoTE
- Pós-CVE: anticoagular "e 4 semanas

Drogas de frequência

Dica - Drogas de frequência

Betabloqueador ou antagonista de cálcio não DHP (verapamil/diltiazem) se FE preservada; digoxina adjuvante/sedentário; amiodarona se IC descompensada selecionada.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1